EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 76076
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-12-20 11:56:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: HORTENCIA DEL CARMEN VALENZUELA ARAVENA			RUN	: 6.771.488-1
F.Nac	: 20-12-1947	Edad	: 76 AÑOS	Género	: Femenino
Dirección	: SECTOR TOQUIHUA SAN CARLOS			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA A	Teléfono	: 985787114		
Fecha Ingreso	: 2023-12-19	Fecha Egreso	: 2023-12-20 11:56:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. G45.9-ISQUIMIA CEREBRAL TRANSITORIA, SIN OTRA ESPECIFICACION

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV isquémico brazo posterior de cápsula interna izquierda, etiología obs lacunar
-Demencia
-Institucionalizada

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente ingresada en contexto de cuadro de evolución corta caracterizado por disatria asociado a disminución de FM generalizada, de predominio en hemicuerpo derecho. Actualmente sin familiar disponible para recabar información. Paciente con escaso aporte dentro de condición basal. Durante exploración en sala destaca: Piel: Cambios y signos propios de la edad CP: Torax asimétrico, normoexpansible, RSRSPS, escasos estertores bibasales, RSCSRSRS SS NG Abdomen: RHA+, sin megalias.

Evolución
Paciente en BEG, HDN con HTA moderada, RS al monitor, afebril, eupneica, tolera bien régimen papilla+líquido fino, logra SBC con buen control de tronco, estable en déficit neurológico, impresiona en regresión.
TC cerebro s/c de control muestra infarto agudo de aspecto lacunar en brazo posterior de cápsula interna izquierda, sin lesiones hemorrágicas. AngioTC cerebro y cuello sin estenosis significativas.
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio hoy, DAPT por 21 días y control ambulatorio en policlínico de Neurología con exs pendientes (ETT, Holter de ritmo).

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio hoy
-DAPT por 21 días, luego solo AAS
-Suspender gemfibrozilo
-Reiniciar tto crónico usual. Evaluar pertinencia de dosis actuales de haloperidol y trihexifenidilo con tratante
-Control ambulatorio en policlínico de Neurología con exs pendientes (ETT, Holter de ritmo)
-IC HODOM KNTM y Fonoaudiología

INDICACIONES AL ALTA

1. -Aspirina 100 mg/d
2. -Clopidogrel 300 mg hoy, desde el 21/12/23 75 mg/d por 20 dias y luego suspender

3. -Atorvastatina (40 mg) 2 comp/noche
4. -Famotidina 40 mg/d
5. -Amlodipino 10 mg/d

EXÁMENES Y RESULTADOS

18/12/23
-Glic 115 Hb glic 5.2
-Crea 0.4 MDRD 155.19 Uremia 37
-AU 3.2
-Ca 10.4
-FA 164 BI 0.08 BD 0.32 BT 0.4 GOT 23 GPT 14 GGT 14
-ColT 174 TG 155
-LDH 142
-Lact 1.1
-Hb 11.2 Leu 8200 Plaq 323000 Seg 45
-INR 1.01 TTPA 28
-TSH 4.308 T4L 0.84
-Pendiente B12, folato, RPR

OBSERVACIONES:

Ex fco gral
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RR 2T no ausculto soplos
-Pulmonar: MP(+) SRA
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos+/+

Ex neurológico
-Mental: vigil, OTE, impresiona adecuadamente atingente, lenguaje N, distingue derecha-izquierda cruzando linea media
-PC: CV N, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, leve exotropia OI, PFC der leve, nistagmo(-), pares bajos impresionan N
-Motor: BC der M4+, BC izq M5, RCP extensor derecho y flexor izquierdo
-Sensitivo: impresiona conservado
-Cerebelo: conservado
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO